肺结核 ★★★（0~3 题）

长期低热，多盗汗、咯血（多为痰中带血 - 与毛细血管有关）
①浸润型肺结核（最常见的继发性肺结核）：境界不清的云雾影、可有薄壁空洞
②慢纤空：厚壁空洞、广泛纤维化、肺门抬高、垂柳影、纵隔向患侧移位
③干酪性肺炎：可高热，可有大叶性实变、虫蚀样空洞

可能可能最可能（2020、2024）

检查

- PPD 检出是否感染结核杆菌、并非检出结核病（2009、2015、2016）
  - PPD 呈阴性或弱阳性：长期用激素或免疫抑制剂、癌症、严重细菌感染、粟粒性结核、麻疹、水痘、HIV、结核性脑膜炎、营养不良“苏一爱洗礼、麻豆爱挠痒”
- X 线→ CT
  - 继发性肺结核好发于上叶尖后段、下叶背段和后基底段“勾肩搭背 hou 基友”（2012）
    合并艾滋病者好发于下叶（2016）
  - 多形性改变：空洞、渗出（斑点 / 片、实变等）、纤维条索、钙化、卫星灶等
- 确诊（2023）
  - 首选痰涂片，金标准痰培养
  - 痰培养阳性（菌阳）→活动性肺结核“活性乳酸菌”，包括：
    ①有传染性：痰涂片阳性（涂阳）→开放性肺结核（排菌量大）
    ②无传染性：痰涂片阴性（涂阴）
  - 3 次痰涂片 +1 次痰培养阴性→菌阴性肺结核
- 判断活动性
  - 无活动性（全满足）：无任何症状（无发热等），痰检查不排菌，X 线钙化 / 硬结 / 纤维化

治疗

早期、联合、全程、适量、短程、规律

抗结核药举例（2015、2018）

	特点	主要副作用
异烟肼（H）	对 A 群最敏感“阿姨”，全杀	肝功损害、周围神经炎 - 手足麻（加 $VitB_6$）“烟 - 炎，麻溜 -6”
利福霉素类如利福平（R）和利福喷丁	对 C 群最敏感“Selina”，全杀	肝功损害（若黄疸→停药）
吡嗪酰胺（Z）	对 B 群最敏感“吡 -B”，细胞内半杀	肝功损害、高尿酸“比内功滋尿”
链霉素（S）	细胞外半杀	肾毒性、耳毒性
乙胺丁醇（E）	抑菌剂“乙 -E- 抑”	视神经炎“丁 - 盯”

活动性肺结核初治：2HRZE/4HR（2 个月强化期 /4 个月巩固期）“2 个好人择偶变 4 个好人”

- RR/MDR-TB（2014）
  - ①短程（首选）：9~12 个月“就要儿子”
    ②长程：≥ 4 种抗结核药、18~20 个月“180 的 20 个儿子”、首选 A 组药利奈唑胺、贝达喹啉、左氧氟沙星 / 莫西沙星“你来北大散心啊”